

Lisaks eelpool nimetatud tegevustele otsustas valitsus kehtestada ka täiendavad puhkepäevad sügava puudega isiku töötavatele pereliikmetele. Eesmärk on ennetada hoolduskoormusega pereliikme tööturult kõrvale jäämist, soodustada paindlikku hooldamise ja töötamise ühitamist ning hoolduskoormuse jagamist pereliikmete vahel. Muudatuse eelnõu on praegu sotsiaalministeeriumis ettevalmistamisel ning jõuab peagi ka avalikule kooskõlastusringile.

Järgmised sammud

Seega võib kokkuvõttes öelda, et rakkerühma tegevuse tulemusena on esimesed muudatused juba töös, kuid lahendamist vajavaid probleeme on hoolekande valdkonnas oluliselt rohkem. Maailmapanga soovitude kohaselt tuleb meil edasi liikuda samm-sammult ja luua esmalt eeldused pikaajalise hoolduse korralduse süsteemiks. See tähendab nii olemasoleva õigusraamistiku ülevaatamist kui ka pikaajalise hoolduse korralduspõhimõtete paika seadmist. **S**

Pikaajalise hoolduse praegused probleemid ja võimalikud lahendused



Gerli Paat-Ahi

analüütik, poliitikauuringute keskus Praxis

Sarnaselt teistele arenenud riikidega suureneb ka Eestis iga aasta eakate osakaal: kui 2016. aastal oli 65+ vanuses elanikke 19% elanikkonnast, siis rahvastikuprognoside kohaselt on neid 2030. aastal 24% ja aastal 2060 juba 30%. Paljud riigid on seadnud eesmärgi eakaid toetada, et nad oleksid võimalikult terved ja saaksid elada võimalikult kaua oma kodus. Selle üheks eelduseks on, et eakad saavad õigel ajal just neile vajalikke lõimitud tervise- ja hoolekandeteenuseid. Praegu on Eesti kõrges eas (vanuses 65+) inimesed, võrreldes oma Euroopa eakaaslastega, oluliselt

halvema tervisega, ja paljud neist vajavad igapäevaseks toimetulekuks kõrvalist abi.

Millist hoolduse korraldust oleks vaja?

Üheks põhjuseks, miks lõimitud hoolduse tagamine on keeruline, on tervishoiu ja hoolekande rahastamine eri allikatest. See tekitab olukorra, kus ühelgi spetsialistil pole ülevaadet sellest, milliseid teenuseid abivajaja saab tervise- ja milliseid hoolekandesüsteemist. Lõimitud hoolduse puhul on väga oluline, et pikaajalist hooldust vajava inimese puhul

oleksid hinnatud nii tema tervishoiu- kui ka hoolekandeteenuste vajadused (vt joonis 1). Seda hindamist peaks kordama teatud aja pärast, kuna vajadused võivad ajas muutuda. Teiseks oluliseks aspektiks integreeritud hoolduse korral on nii abivajaja kui ka tema lähedaste kaasamine ravi- ja hooldusprotsessi. Uuringud on näidanud, et kui koos abivajajaga on läbi arutatud, mis oleksid ravi ja hoolduse eesmärgid (nt võib olla eesmärgiks iseseisev pesemine, kõndimine vms), siis on inimene ka enam motiveeritud ja tulemused paremad. On oluline, et kogu ravi- ja hooldusprotsessi oleksid kaasatud ka erinevate valdkondade spetsialistid nii tervise- kui ka hoolekandesüsteemist (tavaliselt KOV tasandil), näiteks koduõde, perearst, sotsiaaltöötaja. Nende spetsialistide tegevus peaks olema koordineeritud, mis tähendab seda, et oleks vaja juhtumikorraldajat, kes korraldaks abivajaja hindamist, jälgiks pidevalt tema teenuste vajadust ja tagaks, et inimesele oleksid kättesaadavad kõik just talle vajalikud teenused.

Projekt teenuste edasiarendamiseks

Riiklikku süsteemi üleöö muuta ei saa, kuid abi on ka väikestest algatustest. Poliitika-uuringute keskus Praxis osaleb alates 2015. aastast rahvusvahelises projektis SUSTAIN (*Sustainable Tailored Integrated Care for Older People in Europe*), mis keskendub eelkõige kodus osutatavatele pikaajalise hoolduse teenustele. Projekti eesmärk on olemasolevaid teenuseid edasi arendada, tagamaks teenuste patsiendikesksus, fokuseeritus ennetusele, tõhusus, kvaliteet ja turvalisus, ning teha seda selliselt, et edasiarendatud teenused oleksid rakendatavad ka teistes EL riikides. Uuringus osalevad lisaks Eestile ka Austria, Saksamaa, Holland, Norra, Hispaania ja Suurbritannia. Eestis viivad arendusprojekte

ellu kaks pikaajalise hoolduse teenuste pakkujat: koduõendusteenuse osutaja Medendi OÜ ja hoolekande- ja tervishoiuteenuseid osutav SA Alutaguse Hoolekeskus, nende asutuste kliendid ja klientide lähedased. Esmalt kaardistasime mõlema asutuse probleemid ja vajadused, seejärel töötasime koos kõigi asjaosalistega välja nendele probleemidele lahendused, mida nad said ka kohe praktikas katsetada.

Hooldusele saabuva kliendi kohta on liiga vähe infot

Alutaguse Hoolekeskuse puhul selgus kaks peamist probleemi: asutusse saabuvate klientide kohta oli arsti saatekirjal liiga vähe infot; asutuses puudus süsteem, kuhu koondada patsiendi kohta kogutud info. Seetõttu seadis Alutaguse Hoolekeskus omale eesmärgiks luua hea info haldamise ja vahetamise süsteem koos vastava dokumentatsiooniga. Nad töötasid välja põhjaliku vastuvõtuankeedi, mis täidetakse kliendi saabumisel koos tema lähedastega. Seejärel töötati välja uut tüüpi integreeritud ravi- ja hooldusplaan, mida hakati koostama igale kliendile. Plaanis pannakse koos kliendiga paika eesmärgid, milleni inimene tahab jõuda, nt iseseisev pesemine, iseseisev söömine vms.

Elkõige on kirjeldatud sekkumise eesmärgiks tugevdada abivajaja, tema perekonna ja erinevate meeskonnaliikmete (hooldajad, õed, terapeutid, arstid) omavahelist sidet (isegi kui need omavahel kokku ei puutu), pakkuda mitmekülgset personaliseeritud hooldust (sh dubleerimist vältides) ning kohandada hooldusteenus vastavaks kliendi vajadustele. Peamine kasu nimetatud projekti korral seisneks selles, et on olemas kõigile osapooltele arusaadav informatsioon patsiendist ja tema vajadustest ning et seda infot omavahel jagatakse.



Joonis 1. Lõimitud hoolduse ja tervishoiusüsteemi tasakaalustamine (SUSTAINi töögrupp)

Koduõenduse ja -hoolduse osutajad ei tea, mis teenuseid inimene saab

Koduõendusteenust pakkuva Medendi OÜ puhul tuli ühe olulise probleemina välja asjaolu, et koduõde ei teadnud, kes patsiendi kodus veel teenuseid osutab ja mis laadi need teenused on. Näiteks kui koduõde näeb, et inimesel oleks vaja ka hooldustöötajat, siis ta võib küll sellest kohalikule sotsiaaltöötajale teada anda, kuid hiljem ta ei saa kontrollida, kas hooldustöötaja ikka käib või mitte. Teisalt võis juhtuda ka nii, et patsiendil käis kodus kaks koduõde (kuigi haigekassa maksab vaid ühe eest), aga koduõed ise seda ei teadnud. Seda probleemi on arutatud ka ministeeriumi tasemel, kuid seni puudub hea lahendus, kuidas info kättesaadavust parendada. Seetõttu töötas Praxis koos Medendiga välja koduõendus- ja hooldusplaani (edaspidi ÖHP).

ÖHP eesmärk on hoolekande ja tervishoiuteenuste kooskõlastamine ja see töötati

välja koos patsientidega. Plaan sisaldab olulist infot patsiendi, tema ravi, vajaduste ja arengu kohta ning soosib patsiendi ja temaga töötavate spetsialistide koostööd. ÖHP on patsiendi kodus kalendri kujul olemas ning kõik omaksed ja spetsialistid, kes kodus seda inimest külastavad, saavad seda täita ning lugeda, kes ja mida inimesega teeb. ÖHPs on kirjas inimese peamised diagnoosid ja hooldusvajadus. ÖHP erineb analoogsetest eri asutustes kasutusel olevatest plaanidest ka selle poolest, et ÖHPs panevad koduõde ja patsient koos paika eesmärgid, milleni tahtakse jõuda. Plaani elluviimise käigus toimub mõlema poolt pidev hindamine, kui kaugel ollakse eesmärgi saavutamisest ja missugused on seda soodustavad või takistavad tegurid. Lisaks on ÖHPs pikaajalist hooldust vajava inimese emotsionaalse seisundi hindamiskaala, see aitab õigel ajal näiteks tuvastada depressiooni, mis on eakate suurt suitsiidi osakaalu arvestades väga oluline¹.

¹ ÖHP vormi leiab veebiaadressil: www.praxis.ee/wp-content/uploads/2015/08/Tr%C3%BCKifail_KODU%C3%95ENDUS.pdf.

Praeguseks oleme mõlema projekti elluviimisega jõudnud poole peale ning läbi viidud on ka 30 teenusekasutaja esmane hindamine. Mõlema asutuse teenusekasutajad ja lähedased olid uue lähenemisviisiga rahul. Eriti meeldis teenust saanud inimestele see, et koos nendega arutati, mis eesmärgini võiks jõuda. Seetõttu nad tundsid ennast rohkem asjas sees olevana ning see aitas neil endil ka leida motivatsiooni tulemuse saavutamiseks.

Kodus elavate abivajajate puhul oli ka omaste hinnang ÕHP plaanile väga hea, kuna nad said ise näha, mis nende lähedastega tehakse ja kes nendega tegeleb. ÕHP annab lisaks võimaluse ka omastel omi tähelepanekuid teenuseosutajatele edastada (nt, et eakas inimene ei ole mitu päeva hästi söönud vms).

Kuidas edasi?

SUSTAINi projekt kestab veel ligemale aasta ning selle raames tegeleme peamiselt

patsientide, omaste ning töötajate hindamisega: kuidas nad on arendusprojektide rakendamise tulemustega rahule jäänud, kas inimesekesksus on seeläbi paranenud ning kas need projektid on kaasa aidanud ka pikaajalise hoolduse ohutumale osutamisele. Paralleelselt otsime võimalusi, kuidas ÕHP digitaliseerida, et seda oleks eri teenuseosutajatel mugavam kasutada.

Projekti raames saavad webinaride ja lõpukonverentsi kaudu oma kogemusi jagada organisatsioonid kõigist projektis osalenud riikidest, kes viisid ellu mitmesuguseid arendusprojekte. Vahetatakse kogemusi ning otsitakse võimalusi, kuidas saaks väljatöötatud lahendusi jagada ka teiste riikidega. Kõigi riikide arendusprojektid on suunatud eelkõige tervise- ja hoolekande integratsiooni tugevdamisele ning ravikvaliteedi parandamisele.

